



Acide urique et métabolisme phosphocalcique au cours de la grossesse physiologique : étude analytique transversale.



ePOSTER B36

D. Selmi¹, H. Boukrous¹, I. Mazhoud¹, S. Bouhalas, M. Boussaha¹, S. Kahlet¹

¹ Service de BiochimieMédicale, Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Batna.

INTRODUCTION

La grossesse s'accompagne d'importantes adaptations du métabolisme phosphocalcique afin de répondre aux besoins materno-fœtaux. L'acide urique est un biomarqueur reconnu des perturbations métaboliques et vasculaires au cours de la grossesse, notamment dans les troubles hypertensifs gestationnels où une association entre hyperuricémie et hypocalcémie a été documentée. Cependant, les interactions entre l'uricémie et les paramètres du métabolisme phosphocalcique dans les grossesses physiologiques demeurent insuffisamment explorées.

OBJECTIF

Étudier les variations des concentrations sériques du calcium, du phosphore et de l'acide urique selon le trimestre de la grossesse, et rechercher une éventuelle corrélation entre ces paramètres chez des femmes enceintes sans pathologie associée.

DISCUSSION

- La stabilité inter-trimestrielle des concentrations de calcium total et de phosphore sérique observée dans notre cohorte est en accord avec les travaux de Papasotiriou et al. (2017) et Haliloglu et al. (2011), illustrant l'efficience de l'hyperabsorption intestinale adaptative.
- Par ailleurs, le maintien de l'uricémie à des niveaux physiologiques concorde avec les données de Mundkur et al. (2016) attestant de la préservation de la fonction réno-placentaire chez la femme enceinte normotensive.
- Enfin, l'absence de corrélation significative entre l'acide urique et le calcium ou le phosphore rejoint les conclusions de Salako et al. (2003) démontrant l'indépendance de ces voies métaboliques chez la femme enceinte saine. Contrairement aux associations inverses rapportées par Powers et al. (2006) en contexte de pré-éclampsie ou de néphropathie gravidique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

TYPE D'ÉTUDE	Étude analytique transversale
LIEU	EHS Mère et Enfant de Barika
POPULATION	30 femmes enceintes réparties selon le trimestre : T1 (n = 10), T2 (n = 12), T3 (n = 8)
DOSAGES SÉRIQUES	Calcium total (sans correction pour l'albuminémie), phosphore, acide urique
TECHNIQUE	Automate de biochimie Mindray BS-200 ; méthodes colorimétriques et enzymatiques
STATISTIQUES	Kruskal-Wallis (comparaison inter-trimestres) ; corrélation de Spearman ; p < 0,05

RÉSULTATS

L'analyse des paramètres biochimiques sur la cohorte étudiée met en évidence une stabilité des concentrations sériques au cours de la grossesse, sans variation inter-trimestrielle ni corrélation significative avec l'uricémie.

PARAMÈTRE BIOLOGIQUE	CONCENTRATION MOYENNE (± SD)	COMPARAISON INTER-TRIMESTRES (p)	CORRÉLATION AVEC L'ACIDE URIQUE (r ; p)
Calcium total mg/L	96,02 ± 8,5	p = 0,67	r = -0,08 ; p = 0,68
Phosphore sérique mg/L	42,13 ± 5,8	p = 0,54	r = +0,12 ; p = 0,53
Acide urique mg/L	49,06 ± 12,3	p = 0,71	—

Tableau 1. Synthèse des résultats biochimiques et des analyses statistiques .

CONCLUSION

Aucune corrélation significative entre l'acide urique et les paramètres du métabolisme phosphocalcique n'a été observée dans cette étude. Ces résultats suggèrent que les variations de l'uricémie dépendent d'autres mécanismes que les modifications du calcium et du phosphore dans un contexte gestationnel normal. Des études longitudinales sur des effectifs plus importants, incluant des groupes témoins et des patientes présentant des anomalies du métabolisme phosphocalcique, sont nécessaires pour préciser ces interactions et leur intérêt clinique dans la prédiction des complications gestationnelles.